

IDENTIFICACIÓN

Apellido y Nombre:	ADER MANUEL	Número de documento:	45683086	Estado Civil:	
Tipo de documento:	D.N.I.	Edad de Atención:	22 años 0 meses	Sexo:	Masculino
Fecha de nacimiento:	26/04/2004	Dirección de domicilio:	AV. CABILDO 645 5° A	Teléfono domicilio:	1149865834
Lugar de residencia:	CABA	Parentesco:	Madre	Teléfono acompañante:	1149865834
Acompañante:	mejalelaty alejandra	Plan:	CELESTE	Numero de afiliado:	10097779003
Aseguradora:	MEDICUS	Episodio:	44570147	Clase de episodio:	Internados
Lugar de Atención:	HB Central				

Fecha Ingreso: 27/04/2026

Fecha Egreso: 07/05/2026

Epicrisis de egreso hospitalario**Condición de Egreso:** Domicilio sin At. Domiciliaria**Antecedentes personales:****HEMATOLOGÍA**

22 años

Diagnóstico actual:

Síndrome mielodisplásico / leucemia mieloide aguda (SMD/LMA) según clasificación ICC 2022

SMD con exceso de blastos tipo II según clasificación WHO 2022

Recaída temprana post-trasplante alogénico haploidéntico, como LMA secundaria a SMD (38% de blastos)

◆Historia oncohematológica

Diagnóstico inicial: Mayo 2025

SMD en paciente joven

Clasificación ICC: SMD/LMA

Clasificación WHO: SMD con exceso de blastos tipo II

Clasif ICC: SMD/LMA Clasif WHO: EB tipo II

- Scores Pronósticos:

1. IPSS-Mol: RIESGO ALTO (Hb 6/RAN900/plaq10.000/CTG: cariotipo normal/WT1 mutado VAF 40,7%/blastos 9.3%, medulograma 12%)

2. IPSS-R: IPSS*R RIESGO ALTO

◆Tratamientos recibidos

>1ª línea (citoreducción): Azacitidina +Venetoclax → logra 1ª remisión completa (RC)

> 03/09/2025: Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos haploidéntico

Indicación: estrategia con potencial curativo por enfermedad de alto riesgo

Evolución: sin EICH ni reactivación de CMV

Actualmente SMD Riesgo alto de LMA que recae post trasplante como LMA secundaria a SMD FLT3 positivo

◆Tratamiento de recaída

> Azacitidina + Venetoclax

Evaluación D28 (post ciclo 1): 18% blastos mieloides

Infiltración morfológica >20% → enfermedad refractaria

> Citarabina + Midostaurina

Control medular: 26% blastos mieloides → refractaria

> Requirió citorreducción por fase proliferativa:

Hidroxiurea + Citarabina

>27/04: Inicio de 3ª línea (off-label):

Azacitidina + Venetoclax + Gilteritinib

Estudios complementarios:

RMN 17/04: evolución radiológica favorable del proceso inflamatorio/infeccioso del conducto anal

Motivo de internación:

Quimioterapia

Resumen de Internación:

Inicio esquema Esquema actual de tratamiento 3L (27/04/2026)

CTO 7/7: Azacitidina

Día 11/14: Venetoclax 200 mg (ajustado por interacción con isavuconazol)

IDENTIFICACIÓN

Apellido y Nombre: ADER MANUEL

Tipo de documento: D.N.I.

Número de documento: 45683086

Fecha de nacimiento: 26/04/2004

Lugar de atención: HB Central

Episodio: 44570147

Clase de episodio: Internados

Día 11/28: Gilteritinib 120 mg

Intercurrencias:

- NTF foco respiratorio (sinusitis, Rhinovirus/Enterovirus +) en tratamiento con Meropenem (D5)

EF:

Lucido.

HDE. Afebril

Cateter PICC braquial izquierdo, con hematoma

ABDI; RHA+

LABORATORIO:

Hto 26% Hb 8.6 g/dl GB: 200/mm3 Plaq: 27.000/mm3

Comentarios

Se brindan pautas de alarma y educación acorde a diagnostico

- En plan de egreso en el día de la fecha. Vendrá el sábado 09/05 a transfusión de GR y CPDUA

- Ingresará el día lunes 11/05 a internación para soporte transfusional y realización de estudios medulares para evaluación del tratamiento al día 14 de ciclo actual, según resultado se evaluará la suspensión de Venetoclax para reducir toxicidad. Se habla con el paciente explicando plan, entiende.

- Soporte transfusional: 1 CPDUA

- Continúa QMT (venetoclax y gilteritinib)

- Egreso con ciprofloxacina por indicación de infectología

- Control evolutivo

Responsable: SUAREZ SANDOVAL LUIS MIGUEL

No. Matrícula MN176446

Servicio: HEMATOLOGIA



HOSPITAL BRITÁNICO
D. LUIS MIGUEL SUAREZ SANDOVAL
C. M. L. 176.446
HEMATOLOGÍA